

Fecha Última Actualización: 23-09-2024 13:29:21

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Maria Soledad Marin Soto

Edad : 71a 9m 3d

Dirección : Parcela 25 B Rinconada Del Principal

Rut : 6.977.755-4

Fecha Nacto: 20/12/1952

Comuna : Pirque

N° Archivo : 1914506

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 4424 2064

N° Epicrisis

414481

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 22/09/2024 06:59

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 23/09/2024 13:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

shock

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

María Soledad Marin Soto

71 años

FI CASR: 22/09/2024

FI UCI: 22/09/2024

Antecedentes

- Médicos: HTA. Trastorno Depresivo, Trastorno de la Personalidad (Cluster B).
- Quirúrgicos: Fractura Tobillo Izquierdo Operado (Nov/2022), Luxofractura de Lisfranc Operada de Pie izquierdo (Nov/2020).
- Fármacos: Quetiapina 50 mg/PM, Clonazepam 1 mg/PM, Losartan 50-50, Amlodipino, atenolol. Venlafaxina
- Alergias: No refiere.
- Hábitos: TBQ suspendido (IPA20), OH (-), Drogas (-).
- Hospitalizaciones recientes: 26/06 al 02/07/2024 (11 días) UTIM x shock mixto hipovolemico/septico origen gastrointestinal
- Sociales: Dueña de casa. Vive con su madre y dos hijos (divorciada).

Historia clínica

Antecedentes descritos. Hospitalización reciente x 11 días en UTIM con diagnóstico de shock séptico/hipovolemico, origen gastrointestinal en contexto de diarrea en vías de prolongación. Tuvo disfunción HDM-resp-renal, siendo dada de alta con creatinina normalizada (0.86) y aportes de potasio oral más espironolactona en relación a hipokalemias de origen no renal. No tiene controles en ambulatorio posteriores.

Actualmente, cuadro de aprox 10 días de evolución de vómitos en múltiples ocasiones y diarrea, asociando hipoingesta. Agrega debilidad EEII (4 días) y parestesias. El 21/9 presenta compromiso cualitativo de conciencia por lo que consulta en SAPU, derivándose a UEA/HSR.

Evaluada en regulares a malas condiciones generales, PAM (110), FC 90; FR 16; SatO2 96%amb. Afebril

HGT 145, llene capilar 3-4 seg

Ex físico desataca: en sopor superficial, inatenta, mucosas secas, yugulares planas. Abdomen BDI, RHA (+) sin signos de irritación peritoneal. Se administra SRL 1000cc EV, exs y panTAC

->Exs de ingreso (2:30 am) destaca: Crea 11, BUN 72, kalemia 1.93. GB 19.120, Hcto 41%, PQT 402.000

PCR 61, LACTATO 29. Ph 6.9, Bic 8.3

Fecha Epicrisis : 23/09/2024 13:29

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 23-09-2024 13:29:21

Página 2 de 3

Tras su regreso de TAC, se objetiva por equipo enfermería y familiar, paciente en PCR (6 am).

Se traslada a reanimador: Se describe lo sgte, en contexto de falla renal, acidosis severa e hipokalemia severa se administran 4 amp gluconato de calcio, 4 ampollas KCL en 250 cc, 1 matraz bicarbonato 2/3 M.

Paciente RCE a los 8 ciclos, con desfibrilación 1 oportunidad. Se administran adrenalina 4 ampollas (1er ciclo). Se aborda VA intraPCR donde se evidencia aspiración de abundante contenido gástrico.

Paciente cae en PCR nuevamente, se inician maniobras logrando RCE a los 5 minutos. Se instala CVC yugular derecho.

Se conecta a VMI parámetros protectores e inicia soporte HDM llegando hasta tres DVA: noradrenalina 0.4 + adrenalina 0.15 + vasopresina 0.03 UI/min. Sedoanalgesia con Fentanyl y midazolam. Recibe tazepam 4.5 grs ev (sin toma de cultivos previos)

Exs de control, se registra kalemia de 2.04 por lo que se reitera nueva carga de 7 grs KC lev

Dg operativos en UEA:

- 1. Post paro secundario a hipokalemia
- 2. Insuficiencia renal
- 3. Deshidratación secundaria a Sd diarreico y emético

Ingresa a UCI el 22/09/24

Ex Físico:

Perfusión: llene capilar enlentecido > 4 seg, fría a distal. Mottling(1) + moteado en mamas

Piel y mucosas: palida, piel y mucosa seca

C y C: yug(-) 45°

Torax: expande simétrico.

C: RR2T sin soplos

P: MP(+) crepitos bilaterales

Abd: blando y depresible RHA+, sin signos peritoneales

EES: edema(-), pulsos ok

EEl: edema(-), sin signos TVP. Pedios+/-

Neuro: SAS1-2, hace esfuerzo inefectivo, se profundiza sedación. Pupilas mióticas isocóricas, corneales+/-, plantares indiferentes

Diagnósticos de ingreso:

Shock indiferenciado, impresiona multifactorial

->Septico de origen gastrointestinal

->Distributivo/vasoplejico contexto síndrome post PCR

->Hipovolemico 2° pérdidas gastrointestinales

Post PCR recuperado: 8 ciclos + 5 ciclos

->2° hipokalemia severa + acidosis metabólica severa

Sd falla orgánica múltiple:

->Disfunción circulatoria persistente severa: hiperlactatemia (perfil hipóxico), triple DVA

->Insuficiencia respiratoria aguda; Obs SDRA en evolución; Neumonía aspirativa en evolución

->Insuficiencia renal aguda anúrica; prerenalidad + NTA en evolución

->Acidosis metabólica severa AG aumentado

->Hipokalemia severa: pérdidas no renales + Shift

->Hipernatremia en evolución: aportes de hipertónicos contexto reanimación

->IAM SSDST: tipo 2

->CID en evolución

Planes:

Continúa reanimación vigorosa según predictores dinámicos, se realiza diálisis continua y se ajuste tto antibiótico. Pese a medidas paciente presenta shock refractario, evoluciona con falla orgánica múltiples. Pronóstico ominoso, se explico de manera extensa a familiares.

Se objetiva asistolia a las 13:10.

Fecha Epicrisis : 23/09/2024 13:29

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 23-09-2024 13:29:21

Página 3 de 3

Realizo certificado de defuncion y entrego a familiares.

Diagnóstico de Egreso

Shock septico -

Condición de Egreso Fallecido

fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Sebastian Ramirez Henriquez

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 23/09/2024 13:29

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:31

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar